

CAPÍTULO 13.45

Tabaquismo

PERFIL EUNACOM 1.04.1.025

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La faringoamigdalitis es uno de los motivos de consulta más frecuentes en atención primaria y urgencias. Sin embargo, el desafío para el EUNACOM no es solo diagnosticar una amigdalitis pultácea, sino realizar el diagnóstico diferencial preciso con cuadros sistémicos que presentan compromiso faríngeo, como la **Escarlatina**, la **Enfermedad de Kawasaki** y la **Mononucleosis Infecciosa**.

Faringoamigdalitis: ¿Viral o Bacteriana?

La distinción inicial debe basarse en la clínica y, de ser necesario, en escalas validadas como el **Score de Centor**.

Amigdalitis Viral

Se caracteriza por la presencia de **síntomas catarrales** acompañantes. - **Clínica:** Odinofagia, rinorrea, disfonía, tos, y a veces vesículas o aftas. - **Score de Centor:** Habitualmente 0-1 punto. - **Conducta:** Tratamiento sintomático (analgesia, hidratación). No requiere antibióticos.

Amigdalitis Bacteriana (Estreptocócica)

Causada principalmente por *Streptococcus pyogenes* (SGA). - **Clínica:** Fiebre alta, odinofagia intensa, adenopatías cervicales dolorosas, exudado amigdalino bilateral y **ausencia de tos**. - **Manejo según Score de Centor:** - **4-5 puntos:** Alta probabilidad bacteriana. Iniciar antibióticos. - **2-3 puntos:** Dudoso. Idealmente realizar Test Rápido de Strep o Cultivo. - **0-1 punto:** Probablemente viral.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Criterios de Centor (Modificados): 1. Fiebre (>38°C): +1 2. Ausencia de tos: +1 3. Adenopatías cervicales anteriores dolorosas: +1 4. Exudado o edema amigdalino: +1 5. Edad: - 3 a 14 años: +1 - 15 a 44 años: 0 - ≥ 45 años: -1

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

En niños **menores de 3 años**, la amigdalitis bacteriana por SGA es extremadamente rara. Ante un niño pequeño con fiebre y exudado, lo más probable es una etiología viral, frecuentemente por **Adenovirus**.

Diagnóstico Diferencial de Faringitis con Exantema

Cuando el cuadro faríngeo se acompaña de un exantema (rash), el abanico diagnóstico se amplía a patologías de alta relevancia en el examen.

1. Escarlatina

Es una complicación no supurativa de la infección por *S. pyogenes* productor de **toxina eritrogénica**. - **Exantema característico:** Descrito como "piel de gallina" o papel de lija (micropapular). - **Líneas de Pastia:** Petequias lineales en pliegues (fosa antecubital, axilas). - **Triángulo de Filatov:** Palidez perioral (respeta el área alrededor de la boca y nariz), similar a lo que se ve en el **Lupus Eritematoso Sistémico**. - **Laboratorio:** Neutrofilia marcada. - **Tratamiento:** Igual que la amigdalitis pultácea. **Penicilina benzatina** (1.2 millones UI si pesa >30kg) o Amoxicilina por 10 días.

2. Enfermedad de Kawasaki

Es una vasculitis de medianos vasos que puede comprometer las arterias coronarias. - **Clínica clave:** - Ojo rojo (conjuntivitis no purulenta). - Boca roja (labios fisurados, lengua en fresa). - Edema o descamación de manos y pies. - Adenopatía cervical (generalmente única y >1.5 cm). - Exantema polimorfo. - **Conducta:** 1. Solicitar **Ecocardiograma** (buscar dilatación de coronarias). 2. Iniciar **Inmunoglobulina G endovenosa (IGIV)** (lo más importante para prevenir aneurismas). 3. Aspirina a dosis altas.

3. Mononucleosis Infecciosa

Causada habitualmente por el virus de Epstein-Barr (VEB). - **Tríada clásica:** Fiebre, faringitis (con exudado blanquecino/grisáceo) y linfadenopatías difusas. - **Laboratorio:** Linfocitosis con linfocitos atípicos. - **Exantema tras antibióticos:** Un signo clásico para el EUNACOM es la aparición de un **rash morbiliforme** (similar al sarampión) tras la administración accidental de **Amoxicilina** o Ampicilina (ocurre en

el 90% de los casos). - **Otros hallazgos:** Esplenomegalia, hepatomegalia e ictericia.

NOTA CLÍNICA

La esplenomegalia en la mononucleosis conlleva un riesgo de **rotura esplénica**. Se debe recomendar al paciente evitar deportes de contacto por al menos 3 a 4 semanas.

Resumen Comparativo para el EUNACOM

TABLA 13.45.1: PATOLOGÍA VS HALLAZGO FARÍNGEO				
PATOLOGÍA	HALLAZGO FARÍNGEO	CARACTERÍSTICAS DEL EXANTEMA	LABORATORIO SUGERENTE	TRATAMIENTO
Amigdalitis Bacteriana	Exudado pultáceo	Generalmente ausente	Leucocitosis / Neutrofilia	Penicilina Amoxicilina
Escarlatina	Exudado pultáceo	Piel de lija, Líneas de Pastia, Triángulo Filatov	Neutrofilia	Penicilina Amoxicilina
Kawasaki	Labios rojos/fisurados	Polimorfo, edema de manos/pies	Reactantes de fase aguda muy elevados	IGIV + Aspirina
Mononucleosis	Exudado grisáceo/blanco	Morbiliforme (gatillado por Amoxicilina)	Linfocitosis atípica	Sintomático

Perlas Clínicas Finales

- Si un paciente tiene **esplenomegalia e ictericia** asociadas a un cuadro faríngeo, piensa de inmediato en **Mononucleosis Infecciosa**.
- Ante un cuadro de faringitis que no mejora con antibióticos y desarrolla un rash generalizado, sospecha que el antibiótico fue el desencadenante de la reacción en una mononucleosis.
- El diagnóstico de **Kawasaki** es clínico, pero la urgencia es el tratamiento con inmunoglobulina para evitar secuelas cardíacas.
- En la **Escarlatina**, el tratamiento antibiótico no es para acortar el cuadro del exantema, sino para prevenir la **Fiebre Reumática**.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

No confundir el triángulo de Filatov (palidez perioral en Escarlatina) con el eritema malar del **Lupus Eritematoso Sistémico**. En la Escarlatina, el resto de la cara está intensamente eritematosa, resaltando la palidez alrededor de la boca.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 55 años, fumador de 20 cigarrillos diarios durante 25 años, consulta para dejar de fumar. Refiere que cuando despierta lo primero que hace es fumar y que ha intentado dejarlo sin éxito en múltiples ocasiones, presentando irritabilidad y ansiedad intensas. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Tabaquismo. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- El tabaquismo es factor de riesgo cardiovascular (ACV, IAM, claudicación), oncológico (pulmón, boca, vejiga, laringe) y respiratorio (EPOC, bronquitis crónica).
- Paquetes-año = (cigarrillos/día ÷ 20) × años de consumo. Ejemplo: 10 cig/día × 30 años = 15 paquetes-año.
- Criterios de adicción: >15 cigarrillos/día, fumar más en la mañana, fumar en lugares prohibidos, fumar a pesar de contraindicaciones médicas.
- Pilar del tratamiento: psicoterapia cognitivo-conductual. Si >15 cig/día con abstinencia → apoyo nicotínico (parches, chicles).
- Bupropión y vareniclina (Champix) disminuyen el craving (deseo de fumar), a diferencia de la nicotina que disminuye el síndrome de abstinencia.
- El consejo médico simple tiene solo 5% de éxito, pero debe hacerse siempre por su bajo costo en tiempo.
- El cigarrillo electrónico no se recomienda de forma general porque mantiene el hábito de fumar.
- Contaminación ambiental: aumenta infecciones respiratorias virales, neumonía, cáncer pulmonar y riesgo cardiovascular.
- Restricción vehicular y prohibición de estufas a leña = prevención primaria, protección de la salud (actúa sobre el medio ambiente).
- Ley antitabaco, restricción publicitaria y advertencias en cajetillas = prevención primaria, promoción de la salud (actúa sobre las personas).

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (TABAQUISMO)**PREGUNTA 1**

Hombre de 55 años, fumador de 20 cigarrillos diarios durante 25 años, consulta para dejar de fumar. Refiere que cuando despierta lo primero que hace es fumar y que ha intentado dejarlo sin éxito en múltiples ocasiones, presentando irritabilidad y ansiedad intensas. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada?

- A)** Consejo médico breve y control en 6 meses
- B)** Psicoterapia cognitivo-conductual más apoyo nicotínico y eventualmente vareniclina
- C)** Indicar cigarrillo electrónico como sustituto
- D)** Iniciar benzodiacepinas para controlar la ansiedad por abstinencia
- E)** Derivar a psiquiatría sin iniciar tratamiento en atención primaria

PREGUNTA 2

Un paciente refiere fumar 30 cigarrillos al día durante los últimos 20 años. ¿Cuántos paquetes-año tiene acumulados?

- A)** 15 paquetes-año
- B)** 20 paquetes-año
- C)** 30 paquetes-año
- D)** 45 paquetes-año
- E)** 60 paquetes-año

PREGUNTA 3

Respecto a las medidas de salud pública antitabaco en Chile, ¿cuál de las siguientes corresponde a una medida de promoción de la salud?

- A)** Restricción vehicular en Santiago
- B)** Prohibición de estufas a leña
- C)** Ley antitabaco que prohíbe fumar en lugares públicos
- D)** Screening de cáncer pulmonar con TAC de baja dosis
- E)** Tratamiento farmacológico del tabaquismo con vareniclina

RESUMEN: TABAQUISMO

El tabaquismo es un factor de riesgo mayor con implicaciones cardiovasculares (ACV, infarto, claudicación intermitente, aneurisma de aorta abdominal), oncológicas (cáncer de pulmón, boca, vejiga, lengua, nariz, esófago, laringe) y respiratorias (EPOC, enfisema pulmonar, bronquitis crónica). Es uno de los factores de riesgo más relevantes evaluados en el EUNACOM por su transversalidad clínica. El concepto de paquetes-año permite cuantificar la exposición acumulada al tabaco. Se calcula dividiendo los cigarrillos diarios por 20 (para obtener cajetillas/día) y multiplicando por los años de consumo. Ejemplo: 10 cigarrillos/día durante 30 años equivale a 15 paquetes-año. Los criterios de adicción incluyen fumar más de 15 cigarrillos al día, fumar más en la mañana, fumar en lugares prohibidos y fumar a pesar de contraindicaciones médicas. El tratamiento del tabaquismo tiene como pilar la psicoterapia cognitivo-conductual. Cuando el paciente fuma más de 15 cigarrillos diarios y presenta síndrome de abstinencia, se agrega apoyo nicotínico (parches, chicles). Fármacos como bupropión y vareniclina (Champix) disminuyen el craving. El cigarrillo electrónico no se recomienda de forma general, aunque es el mal menor frente al cigarrillo convencional. Simplemente aconsejar dejar de fumar tiene solo un 5% de éxito, pero debe realizarse siempre. La contaminación ambiental también es un factor de riesgo relevante: aumenta las infecciones respiratorias virales, el riesgo de neumonía, cáncer pulmonar y riesgo cardiovascular. En Chile, las medidas incluyen restricción vehicular y prohibición de estufas a leña (prevención primaria tipo protección de la salud). Las medidas antitabaco (restricción publicitaria, advertencias en cajetillas, ley antitabaco) corresponden a prevención primaria tipo promoción de la salud, ya que actúan sobre las personas y sus hábitos.